

TEMA 2.17 • GINECOLOGÍA

Métodos Anticonceptivos

PERFIL EUNACOM 2.01.1.082

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Métodos Anticonceptivos

Clasificación General

TABLA 2.17.1: TIPO VS EJEMPLOS		
TIPO	EJEMPLOS	ÍNDICE DE PEARL
Naturales	Billings, coitus interruptus, temperatura	Billings ~2%; otros: muy altos
Barrera	Condón masculino, condón femenino, diafragma	~2%
DIU	T de cobre, DIU medicado (Mirena)	T cobre: baja; Mirena: ~0%
Hormonales	ACO, parche, anillo vaginal, inyectable, implante	Muy baja con uso correcto
Quirúrgicos	Ligadura tubárica, vasectomía	~0% (permanente)

1. Método Billings

- Evalúa el moco cervical para detectar la ventana fértil
- Ventana fértil: **5 días antes de la ovulación + día de la ovulación**
- Útil si ciclo regular; aceptado por el catolicismo
- Índice de Pearl: ~2%

2. Métodos de Barrera

- **Condón masculino:** Único que previene **ETS** → indicación absoluta en sexo casual y promiscuidad
- Contraindicación: alergia a látex → usar poliuretano
- Diafragma: no protege de ETS, poco usado

3. Dispositivo Intrauterino (DIU)

T de Cobre

- Duración: 5–10 años - Riesgos: ↑ dismenorrea, ↑ hipermenorrea, factor de riesgo de PIP - **Contraindicaciones:** Promiscuidad sexual, dismenorrea/hipermenorrea preexistente, endometriosis, (relativa: nuliparidad) - Si embarazo con DIU: retirar (50% aborto de todas formas; sin retiro: mismo % pero + infecciones/complicaciones) - Si PIP con DIU: ATB; retirar solo si no responde en 3 días o actinomicosis sintomática

DIU Medicado (Mirena, levonorgestrel)

- Duración: ~5 años - **Índice de Pearl ~0%** (el anticonceptivo más eficaz disponible) - Beneficio adicional: atrofia endometrial → reduce dismenorrea e hipermenorrea - Contraindicación: solo promiscuidad sexual (riesgo de PIP)

4. Métodos Hormonales

Efectos Adversos Generales de Hormonales

- Náuseas - ↑ riesgo cardiovascular (VO mayor que transdérmico) - ↑ riesgo cáncer de mama - ↓ riesgo cáncer de endometrio (progestágeno atrofia endometrio) - ↓ riesgo cáncer de ovario (bloqueo eje HHO)

Contraindicaciones de ACO (Anticonceptivos Combinados)

- Hepatopatía (aguda o crónica) - Jaqueca/migraña agravada por ACO (relativa) - Lupus eritematoso sistémico (relativa) - **Alto riesgo cardiovascular:** IAM previo, fumadora > 35 años, trombofilia, TVP/TEP previo - **Cáncer de mama** (antecedente personal, NO familiar) - Cáncer de endometrio - Melanoma - Metrorragia de causa desconocida (puede enmascarar cáncer)

Vías de Administración

TABLA 2.17.2: VÍA VS VENTAJA		
VÍA	VENTAJA	INDICACIÓN ESPECIAL
Oral	Simple	Estándar
Transdérmica (parche) o vaginal (anillo)	Sin paso hepático → ↓ riesgo cardiovascular	Dislipidemia, obesidad, HTA
Inyectable	1 vez/mes o c/3 meses	Baja adherencia oral
Implante subcutáneo	Dura varios años	Casos especiales

PERLA CLÍNICA EUNACOM

EUNACOM: Paciente obesa con hipertrigliceridemia que desea anticonceptivo → **vía transdérmica o vaginal** (sin paso hepático).

ACO Combinados Orales

- **Componente estrogénico:** Etinilestradiol
- **Microdosis** (15–20 µg): menos efectos adversos, mayor riesgo de **spotting**
- **Dosis estándar** (30–35 µg): más efectos adversos, menos spotting → indicado si microdosis produce spotting

Componente progestacional:

TABLA 2.17.3: TIPO VS EJEMPLOS		
TIPO	EJEMPLOS	USO
Proandrogénico	Levonorgestrel, norgestrel	Más baratos; contraindicados en SOP/hirsutismo
Neutro	Desogestrel, gestodeno, norgestimato	Efecto andrógeno neutro
Antiandrogénico	Dienogest, drospirenona, clormadinona, ciproterona	Indicados en SOP, acné, hirsutismo

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ciproterona: Efecto antiandrogénico más potente, pero mayor riesgo cardiovascular → usar solo por 2–3 meses en SOP severo.
Levonorgestrel: Proandrogénico → contraindicado en SOP (empeora acné e hirsutismo).

ACO en Lactancia

- Estrógenos: **disminuyen producción de leche** → contraindicados
- Usar **progestágenos solos** (vía oral) durante la lactancia
- **Lactancia materna como método anticonceptivo** (LAM): eficaz solo si:
 - Lactancia materna **exclusiva**
 - Lactante **< 6 meses**
 - **Amenorrea** (sin menstruación)

5. Métodos Quirúrgicos

TABLA 2.17.4: PROCEDIMIENTO VS SEXO		
PROCEDIMIENTO	SEXO	PARTICULARIDAD
Ligadura tubárica	Femenino	Habitualmente en cesárea; si embarazo post-ligadura → ectópico seguro
Vasectomía	Masculino	Menor riesgo quirúrgico que ligadura

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Médico-legal: - Toda mujer tiene derecho a ligadura, aunque sea nulípara - No se puede realizar sin **consentimiento informado firmado** (incluso con 10 hijos) - Hacerlo sin consentimiento → consecuencias penales graves

Ligadura tubárica + dolor hipogástrico + hipotensión → sospechar **embarazo ectópico roto** (aunque es raro, si ocurre un embarazo post-ligadura es necesariamente ectópico).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Clasificación General
- 1. Método Billings
- 2. Métodos de Barrera
- 3. Dispositivo Intrauterino (DIU)
- T de Cobre
- DIU Medicado (Mirena, levonorgestrel)
- 4. Métodos Hormonales

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"En relación a Métodos Anticonceptivos: Hormonales | ACO, parche, anillo vaginal, inyectable, implante | Muy baja con us... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Métodos Anticonceptivos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS)**PREGUNTA 1**

En relación a Métodos Anticonceptivos: Hormonales | ACO, parche, anillo vaginal, inyectable, implante | Muy baja con us... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Métodos Anticonceptivos se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Métodos Anticonceptivos debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Métodos Anticonceptivos requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Métodos Anticonceptivos es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Métodos Anticonceptivos no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Métodos Anticonceptivos?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Métodos Anticonceptivos. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

:::tip EUNACOM: Paciente obesa con hipertrigliceridemia que desea anticonceptivo → vía transdérmica o vaginal (sin paso hepático). :::

:::warning Ciproterona: Efecto antiandrogénico más potente, pero mayor riesgo cardiovascular → usar solo por 2–3 meses en SOP severo. Lactancia materna como método anticonceptivo (LAM): eficaz solo si: 1. Lactancia materna exclusiva 2. Lactante < 6 meses 3. Amenorrea (sin menstruación)